

12주차 1교시. 청소년과 약물남용

1. 약물남용의 개념적 정의

1) 약물남용의 정의

- 사용하기 시작하면 사용하고 싶은 충동을 느끼고(의존성), 사용할 때마다 양을 늘리지 않으면 효과가 없으며(내성), 사용을 중지하면 온몸이 건디기 힘든 이상을 일으키고(금단증상), 개인에게 한정되지 않고 사회에도 해를 끼치는 물질(세계보건기구, WHO)

2) 약물남용의 개념

- 약물남용은 향정신성약물(인간의 중추신경계에 작용하는 약물)의 비의학적 사용을 의미
- 즉, 사람의 감정, 인식, 행동에 인위적인 변화를 일으키기 위해 의료의 목적과는 관계없이 중추신경계에 영향을 미치는 약물을 계속적으로 사용하는 것
- 약물남용은 임상적으로 중대한 장애나 고통을 초래하는 약물사용의 병리학적 양상
- 약물남용은 의료행위의 규정에 맞지 않게 약물을 지속적이며 산발적으로 과용하는 것이며, 약물남용이 지속되면 약물의존으로 발전(WHO)
- 약물남용이란 치료 또는 예방이 목적이 아니라 쾌락이 주된 사용동기이며, 비의학적인 특성을 가지고 있다. 또 신체적, 정신적, 사회적인 손상을 가지고 오며 강한 중독성과 의존성을 나타내어 약물이 중단되면 금단현상이 나타난다.

[임상적 약물남용 진단기준(DSM-IV-TR)]

- 다음에 열거한 항목 가운데 3개 이상 항목이 나타난 경우 약물남용이라 진단할 수 있다.
 - ① 반복적인 약물사용으로 직장, 학교, 가정에서의 중요한 역할을 수행하지 못한다.
예를 들어, 약물사용으로 인해 학교에 결석하거나, 징계를 당한다.
 - ② 신체적으로 해를 주는 상황에서 반복적으로 약물을 사용한다.
예를 들어, 약물사용으로 인해 손상이나 장애가 초래된 상황을 말한다.
 - ③ 반복적으로 약물 사용과 관련된 법적 문제를 일으킨다.
예를 들어, 약물사용과 관련된 탈선 행동으로 체포된 경험이 있는 경우가 해당된다.
 - ④ 약물의 효과로 인해 사회적 문제나 대인 관계 문제가 지속적으로 또는 반복적으로 야기되거나 악화되에도 불구하고 계속 약물을 사용한다.
예를 들어, 중독의 결과로 배우자와 언쟁하거나 몸싸움을 한다.

3) 약물의존의 정의

- 불안한 상태에서 벗어나기 위해 계속 약물을 사용해야 하는 상태(정신적 의존)이거나, 신체적 금단증상을 막기 위해 약물이 더 많이 필요한 상태(신체적 의존)를 말한다. 즉, 약물의존은 약물에 대한 정신적·신체적 중독 상태이다.

[WHO의 약물의존 진단기준(ICD-10)]

- 다음의 8가지 증상 중에서 3개 이상의 증상을 가지는 경우를 약물의존으로 정의한다.
 - ① 금단증상이 생리반응으로 나타난다.
 - ② 금단증상을 완화시킬 목적으로 약물을 사용하며, 이 방법이 효과가 있음을 알고 있다.
 - ③ 초기에는 소량의 약물로 얻을 수 있었던 효과를 얻기 위해, 더 많은 양의 약물을 사용해야 한다.
 - ④ 술이나 약물을 섭취하기 위한 강렬한 욕망이나 충동을 느낀다.
 - ⑤ 약물 사용의 시작, 중단, 용량 조정 등 술이나 약물의 사용을 조절하는 능력에 장애가 있다.
 - ⑥ 술이나 약물 때문에 행동반경이 좁아진다.
 - ⑦ 약물사용 때문에 자신이 좋아하던 것을 점차 무시하게 된다.
 - ⑧ 약물로 인해 분명한 해를 입었음에도 불구하고 술이나 약물을 계속 사용한다.

2. 약물의 유형과 약물남용의 요인

1) 약물의 유형

- 중추신경에 작용하는 약물은 중추신경을 억제시키느냐, 흥분시키느냐, 두 가지 작용이 한꺼번에 나타나느냐에 따라 크게 세 가지로 나눈다. 중추신경을 흥분시키는 약물을 중추신경흥분제, 억제시키는 것을 중추신경억제제, 두 가지 작용이 한꺼번에 일어나는 것을 환각제라고 한다.

중추신경흥분제	▪ 뇌신경 세포의 기능을 흥분시키는 약물 ▪ 담배, 카페인, 암페타민, 필로폰, 코카인 등
중추신경억제제	▪ 뇌신경 세포의 기능을 억제시키는 약물 ▪ 알코올, 흡입제(부탄가스, 본드 등), 마약류, 수면제, 신경안정제, 텍스트로메토르판, 항히스타민제
환각제	▪ 뇌신경 세포의 기능을 흥분시키기도 하고 억제시키기도 하는 약물 ▪ 대마초, LSD, PCP, 엑스터시 등

(1) 담배

- 담배의 주요 성분은 니코틴, 타르, 일산화탄소 등이다.
- 금연상담전화서비스(1544-9030)는 2006년 4월부터 일반인 누구에게나 금연과 흡연예방을 위한 정보제공은 물론 전문 금연상담사가 흡연자에 대하여 금연의지 확인, 금연결심, 금연실천, 금연유지 등의 단계별 금연상담을 1년간 프로그램으로 제공하고 있으며, SMS문자 서비스, 이메일 서비스 등의 다양한 상담 채널을 제공하고 있다.

(2) 알코올

- 알코올(Alcohol)은 물과 에탄올로 구성되어 있으며 무색의 액체이다.
- 알코올 중독으로 신체에서 가장 손상을 받는 장기는 뇌와 간이다.
- 미국의학협회, WHO, 그리고 중독학회 등에서는 '조절 능력의 상실'과 '부정적 결과'에도 불구하고 계속적으로 알코올을 사용할 때 '알코올 의존증(알코올 중독증)'이라고 정의하고 있다.
- 임신 중 여성이 알코올을 섭취하면 태아알코올증후군을 가진 아기를 출산할 가능성이 높다.

(3) 본드 및 부탄가스

- 흡입제란 본드, 시나, 부탄가스 등 일상생활에 사용되는 유해화학 물질로서 코나 입을 통해서 들어 마심으로써 우리 몸(폐)에 들어와 정신이나 육체의 변화와 신체 및 정신 건강에 치명적인 손상을 입히는 물질을 말한다.
- 흡입제의 주성분인 톨루엔은 신경억제작용을 하는 용매로 인체에 지방대사를 파괴하여 골, 뇌, 간, 신장 등에 심한 조직 손상을 일으킨다.
- 흡입제의 사용 목적은 명정효과를 느끼기 위한 것이다. 명정효과란 병적인 행복감을 유발시키고 가벼운 의식장애와 불안이 따르면 어린아이와 같은 태도를 보이게 되는 것이다.

(4) 코카인(Cocaine)

- 남미가 원산지인 코카나무의 잎에서 활성 알칼로이드를 화학적으로 추출한 물질을 말한다.
- 코카인은 1880년대 만병통치약으로 널리 사용되었으며, 프로이드도 이 물질의 임상효과를 연구한 바 있다.
- 코카인을 흡입할 때 생기는 쾌감의 효과는 일시적으로, 30분 뒤에는 없어진다. 가장 흔한 금단현상은 우울증이다.

(5) 암페타민(Amphetamine)

- 코카인과 유사한 효과의 합성 흥분제이다.
- 알코올중독, 파킨스병, 가벼운 우울증, 기면증, 간질, 수면발작 등의 치료제이다.
- 사회적으로 가장 문제되는 것은 메스암페타민인 필로폰(Philoapon)이다.
- 우리나라에서 '죽음의 백색가루'인 필로폰이 학생들에게는 '정신집중 약', 일반인에게는 '피로회복제', 가정주부에게는 '살 빼는 약'으로 선전되어 은밀하게 팔리고 있다.
- 암페타민이 신체에 미치는 영향으로는 심박동 증가, 혈압 상승, 식욕 저하, 호흡률 증가, 불면, 발한, 갈증, 근육연축, 경련, 발열 등이며, 정신에 미치는 영향으로는 피로감 감소, 자신감 증가, 주의력 증가, 활동 증가, 민감성 증가, 불안, 걱정, 불신감, 환각 등이다.

(6) 마약

- 마약(麻藥)은 양귀비의 추출물로 마약에는 아편과 아편에서 얻어진 모르핀 · 코데인 · 헤로인 등이 있고, 모르핀과 유사한 작용을 하는 순수합성물질인 메사돈 등이 있다.
 - ① 아편 : 마취제, 지사제(설사를 그치게 하는 약), 진통제로 사용된다.
 - ② 모르핀 : 강력한 진통제로 헤로인과 같이 중추신경계와 위장에 주로 효과를 나타낸다.
 - ③ 코데인 : 모르핀의 4분의 1 정도의 진통작용이 있으며, 기침을 진정시키는 진해제로 시판되고 있어 구입이 수월하여 남용되기 쉬운 약물이다.
 - ④ 헤로인 : 모르핀을 화학적으로 변형하여, 보다 강력하게 만든 불법약물로 오늘날 가장 널리 남용되는 마약이며, 미국에서는 남용되고 있는 마약의 약 90%를 헤로인이 차지하고 있다.
- 마약이 신체에 미치는 영향은 동공축소, 통증감소, 변비, 가려움, 졸리움, 호흡억제, 혼수 등이며 정신에 미치는 영향으로는 행복감, 불안 공포, 몽롱, 집중력상실, 무관심 등이다.

(7) 마리화나(Marijuana, 대마초)

- 마리화나는 대마에서 추출된 화학물질이다.
- 헤시시(Hashish)는 대마 암그루의 꼭대기 부위로서, 대마가 성숙할 때 윗부분에 생성되는 끈적끈적한 황색 수지로 만든 것으로 마리화나보다 8~10배가량 작용이 강하다.
- 일반적으로 알려진 마리화나의 가장 큰 부작용은 돌발적인 공포와 불안반응이다.
- 정신에 미치는 영향으로는 술 취한 느낌, 행복감, 충동적 행동, 집중력 감소, 근심, 자신과 신체가 분리된 느낌, 환각증상 등이다.

2) 청소년 약물남용의 요인

(1) 개인적 요인

- 개인적인 위험요인으로 충동조절문제, 정서적 불안정, 스릴을 찾는 행동, 약물 위험에 대한 인식부족, 성인행동에 대한 모방심리, 호기심 등이 있다.
- 청소년 개인의 성격적 결함(반항심, 비동조적인 기질, 낮은 자아존중감과 반사회적 태도 등)이나 문제행동(가출, 성관계, 절도, 폭력, 무단결석, 흥기소지 등)에 의하여 약물을 남용할 수 있다.

(2) 사회환경적 요인

① 가족력과 가족관계의 요인

- 부모는 청소년의 약물사용에 다음의 세 가지 측면을 통해서 영향을 준다.
 - 약물사용 및 남용에 관한 부모의 행동
 - 약물에 대한 부모의 태도
 - 부모와 자녀 간의 상호작용
- 가족 간의 갈등, 부모의 지도부족, 가혹한 육체적 학대, 역기능적인 의사소통, 부모의 무관심과 일관성 없는 양육태도, 가족 내 상호작용 등
- 알코올 중독자의 부모의 영향, 가족의 사회적 고립

② 또래집단

- 청소년들에 있어서는 동료의 압력이나 영향이 약물남용 양상의 시작과 지속성에 중요한 역할을 한다.
- 약물사용의 동기 : “친구들이 모두 약물을 사용한다.”, “친구들과 함께 어울리기 위해 사용한다.”
- 또래집단을 통한 약물의 구입처, 사용법, 장소 등 약물에 관한 정보교환과 관련된 기술 및 비행학습

③ 학교환경

- 낮은 학교성적 및 학교생활 흥미도, 부정적인 교사·학생관계, 부정적인 또래관계
- 교내에서의 음주와 흡연학생에 대한 방관적인 태도
- 교사의 흡연과 음주에 대한 모방태도

④ 사회문화적 요인

- 약물구입의 용이성과 매스미디어의 영향
- 술을 상대에게 권하는 성인문화에 동화
- 급격한 산업화와 도시화로 인한 가치관의 논란과 향락중심의 문화 등으로 약물사용
- 대중매체를 통한 약물광고에 대한 유혹

3) 약물남용이 청소년에게 미치는 영향

- ① 청소년기는 신체적, 정신적으로 중요한 발달과제를 성취해야 하는 시기이므로 이 시기에 인체에 해로운 물질을 사용하게 되면 신체적·정신적 발달에 부정적인 영향을 받게 된다.
 - 향정신성 물질은 뇌의 발달과 활동에 치명적인 영향을 미치며 호흡기, 소화기, 신경계 장애를 초래한다.
 - 약물중독으로 인해 건강한 인격과 자아정체감을 형성할 시기에 정체감 혼란을 초래할 수 있으며, 반사회적 성격, 수치심과 죄의식, 의존심 확대와 자립감 박탈 등으로 낮은 자아존중감을 형성할 수 있다.
- ② 청소년이 약물남용을 하게 되면 어울리는 친구들이 바뀌고, 집안에 틀어박혀 있거나 독립된 공간을 원하며 행동과 태도의 변화가 나타난다.
 - 이해할 수 없는 장기간의 가출, 거짓말, 도둑질, 범법행위 등을 하며, 가족과의 불화와 학교결석이 잦고, 학교활동이 줄어들며, 지나치게 잠을 많이 자고, 이해할 수 없는 행동 등을 한다.
- ③ 청소년이 약물중독에 빠지는 원인 중 하나는 성인의 흉내를 내면서 자신을 성인과 동일시하기 때문이다.
 - 청소년은 자신에게 가해지는 성인의 제재를 거부하며 그것에서 벗어나려는 반항심과 반발심을 갖게 된다.
 - 성인의 흉내를 내보고 금지된 행위를 해봄으로써 청소년은 심리적 만족감을 느끼게 되어 이러한 행위를 지속하게 되는 것이다.
- ④ 약물중독 청소년은 술, 담배와 같은 비교적 가벼운 물질을 경험하는 지위비행에서 시작하여, 시간이 지남에 따라 본드, 부탄가스와 같은 흡입제, 필로폰과 같은 마약류 등으로 발전해 나가는 경향이 있다.
 - 이러한 약물구입을 위해 거짓말, 절도, 강도 등의 범죄행위를 저지르기도 한다.
 - 약물에 취한 상태에서 또래집단의 부정적 영향으로 또래와 어울리거나 단독으로 범죄행위를 하기도 한다.

3. 약물남용 단계와 예방

1) 청소년 약물남용의 단계

- 마이센(Meisener, 1994)은 약물 사용을 4단계로 구분하였다. 실험단계, 사용단계, 남용단계 및 의존단계로, 그 정도가 깊은 단계로 갈수록 치료의 어려움이 많고 재발률이 높다고 하였다.
- 1~2단계의 약물사용자는 개인상담, 가족상담, 집단상담 등 상담적 접근이 효과적인 반면 3~4단계의 약물사용자는 다시 사회에 적응할 수 있도록 도와주기 위해서는 아주 광범위하고 포괄적인 개입이 필요하다고 주장하였다.

[표 12-1. 약물남용의 단계 및 특징]

단 계		특 징
1단계	실험단계	▪ 약물에 대한 호기심 ▪ 친구나 주변의 권유로 약물 시도 ▪ 실험적 혹은 사회도구적으로 약물사용 ▪ 청소년기의 심리·사회적 특징에 의한 시도 ▪ 사회적응에는 심각한 문제가 없으나 약물사용의 충동을 경험 ▪ 약물의 긍정적인 보상을 인식(감정조절, 즐거움 등)
2단계	사용단계	▪ 약물로 인한 감정 변화가 학교생활이나 개인생활에 영향을 줌 ▪ 여러 가지 약물 시도 ▪ 약물사용 빈도 및 사용량 증가 ▪ 약물로 인한 감정(짜증, 분노, 기분 좋은 느낌 등)의 변화를 경험
3단계	남용단계	▪ 역기능적인 행동으로 인한 심각한 문제발생(대인관계손상, 법적문제, 학교생활문제 등) ▪ 여러 가지 문제가 반복적으로 일어나거나 악화됨에도 불구하고 계속해서 약물사용 ▪ 약물로 인한 신체적 문제를 경험
4단계	의존단계	▪ 내성이 생김 ▪ 약물조절능력 상실 ▪ 지속적이며 만성적인 약물 사용 ▪ 금단증상(심한 두통, 메스꺼움, 손떨림, 식은땀, 환시, 환청 등)을 경험 ▪ 생활전체에 대한 통합적 개입이 요구 ▪ 치료받지 않으면 사망의 가능성이 높음

2) 청소년 약물남용의 예방

(1) 약물남용 패턴에 대한 평가

- ① 약물남용의 일반적 패턴 : 시작 시기 및 사용기간, 종류, 구입요령
- ② 약물남용의 정도 : 실험-사용-남용-의존
- ③ 약물남용의 방식 및 충동패턴 : 혼자 사용하는지 혹은 집단으로 어울려서 사용하는지 여부, 충동조절 여부, 위험상황
- ④ 사고·심리·정서 상태

(2) 청소년 약물남용 예방을 위한 개입방안

- ① 담배와 알코올사용 및 남용을 예방하기 위한 교육 및 개입 프로그램이 보다 적극적으로 이루어져야 한다.
- ② 우리나라는 약물사용 및 남용자에 대한 강경책(형사처분)을 쓰고 있다. 치료가 필요한 클라이언트 입장에서 약물남용 청소년들을 이해하고, 치료와 재활 프로그램을 활성화 함으로써 사회에 복귀할 수 있도록 원조해야 한다.
- ③ 청소년 약물남용을 관장하는 정부 부처가 산발적으로 확장되어 있다. 예방과 개입에 대한 일관성을 갖기 위한 관련 부처 간의 적극적인 교류가 요구된다.

(3) 약물남용 주요 관련법규

- ① 마약류관리에 관한 법률(2000. 1. 12. 제정)
 - 제1조(목적) : 이 법은 마약·향정신성의약품·대마 및 원료물질의 취급·관리를 적절히 함으로써 그 오용 또는 남용으로 인한 보건상의 위해를 방지하여 국민보건 향상에 이바지함을 목적으로 한다.
- ② 화학물질관리법(1990. 8. 1. 제정)
 - 제1조(목적) : 이 법은 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해(危害)를 예방하고 유해화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경을 보호하는 것을 목적으로 한다.
- ③ 청소년 보호법
 - 제1조(목적) : 이 법은 청소년에게 유해한 매체물과 약물 등이 청소년에게 유통되는 것과 청소년이 유해한 업소에 출입하는 것 등을 규제하고 청소년을 유해한 환경으로부터 보호·구제함으로써 청소년이 건전한 인격체로 성장할 수 있도록 함을 목적으로 한다.

[표 12-2. 청소년 유해약물의 청소년보호법상 규제내용]

위반사항	위반하는 행위	
	형사처벌	과징금
청소년 대상 판매·대여·배포 (주류, 담배)	2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금	위반 횟수마다 100만원
청소년 대상 판매·대여·배포 (환각물질)	3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금	
청소년 유해표시	2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금	시정명령

■ 학습정리

1. 약물남용의 개념적 정의

- 세계보건기구(WHO)의 정의 : 사용하기 시작하면 사용하고 싶은 충동을 느끼고(의존성), 사용할 때마다 양을 늘리지 않으면 효과가 없으며(내성), 사용을 중지하면 온몸이 견디기 힘든 이상을 일으키며(금단증상) 개인에게 한정되지 않고 사회에도 해를 끼치는 물질
- 약물남용 : 치료 또는 예방이 목적이 아니라 쾌락이 주된 사용동기이며, 비의학적인 특성을 가지고 있다. 또 신체적, 정신적, 사회적인 손상을 가지고 오며 강한 중독성과 의존성을 나타내며 약물이 중단되면 금단현상이 나타난다.
- 약물의존 : 불안한 상태에서 벗어나기 위해 계속 약물을 사용해야 하는 상태(정신적 의존)이거나, 신체적 금단증상을 막기 위해 약물이 더 많이 필요한 상태(신체적 의존)를 말한다. 즉, 약물의존은 약물에 대한 정신적·신체적 중독 상태이다.

2. 약물의 유형

- 중추신경에 작용하는 약물은 중추신경을 억제시키느냐, 흥분시키느냐, 두 가지 작용이 한꺼번에 나타나느냐에 따라 중추신경억제제, 중추신경흥분제, 환각제로 구분한다.

3. 약물남용 단계와 예방

① 실험단계

- 약물에 대한 호기심, 친구나 주변의 권유로 약물 시도
- 실험적 혹은 사회도구적으로 약물 사용
- 청소년기의 심리·사회적 특징에 의한 시도
- 사회적응에는 심각한 문제가 없으나 약물사용의 충동을 경험
- 약물의 긍정적인 보상을 인식(감정조절, 즐거움 등)

② 사용단계

- 약물로 인한 감정 변화가 학교생활이나 개인생활에 영향
- 여러 가지 약물 시도하고 약물사용 빈도 및 사용량 증가
- 약물로 인한 감정(짜증, 분노, 기분 좋은 느낌 등)의 변화를 경험

③ 남용단계

- 역기능적인 행동으로 인한 심각한 문제발생(대인관계손상, 법적문제, 학교생활문제 등)
- 여러 가지 문제가 반복적으로 일어나거나 악화됨에도 불구하고 계속해서 약물 사용
- 약물로 인한 신체적 문제를 경험

④ 의존단계

- 내성이 생기고, 약물조절능력을 상실하며, 지속적이고 만성적인 약물 사용
- 금단증상(심한 두통, 메스꺼움, 손떨림, 식은땀, 환시, 환청 등)을 경험
- 생활전체에 대한 통합적 개입이 요구되며, 치료받지 않으면 사망의 가능성이 높다.